

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА 8-9 НЕДЕЛЕ

Цели:

- Уменьшить отек в плечевом суставе.
- Увеличить объем движения в суставе.
- Увеличить тонус и локальную выносливость мышц манжеты ротаторов, мышц стабилизаторов лопатки.
- Защита. Ношение брейса, по назначению травматолога, до 4-6 недель.

Противоотечные мероприятия:

Холод (2-5*С) на передне - верхнюю поверхность плеча, с захватом акромиально - ключичного сустава, по 10 мин, не меньше 5-6 раз в день - первый месяц реабилитации. Чаще при дискомфорте, либо после нагрузки и **перед сном**. Одна процедура холода - 10 минут приложили, 10 минут перерыв, и снова приложили на 10 минут. При необходимости, холод можно использовать неограниченное количество раз за день. **Далее, при отсутствии дискомфорта**, после 4х недель от операции, можно перейти на 3-4х разовое использование холода.

Физиотерапевтическое лечение: Массаж в электростатическом поле, Магнитотерапия – против боли и отека.

При боли - Дип Рилиф гель - 2-3 раза в день, в 2 слоя.

Рекомендовано:

Питьевой водный режим 30-40 мл на кг веса.
Белковое питание – молодое красное мясо.

Исключить!!!!

- Посещение бани и сауны и других тепловых процедур, до 13 недель.
- Подъем и ношение тяжелых предметов в оперированной руке, на весь период реабилитации, до 1кг.
- Падения и травмы.
- Нагрузка на зону репарации – весь период реабилитации!
- Любые физические нагрузки - активные, быстрые, резкие движения оперированной рукой, спорт, бег, тряску, выраженную и умеренную вибрацию, падения, до 13 недель от операции.
- Любые движения, провоцирующие боль. Работаем до дискомфорта!!

- **Горизонтальное приведение плеча** - до 8 недель от операции - тянуться в противоположный карман.
- **Внутреннюю ротацию плеча** - до 8 недель от операции.
- **Активное отведение плеча выше 90 град** – до 8 недель от операции, особенно резкое, или с утяжелением/сопротивлением.
- **Сон на боку**, с оперированной стороны, особенно сон на травмированной руке, которая вытянута вверх, на весь период реабилитации.
- **При вождении автомобиля – правило градусника** - плечо приведено к туловищу, плечевой сустав вверх не поднимаем! Амплитуда движения в плечевом суставе минимальная.

Массаж послеоперационных швов- перемещение кожи во всех направлениях, до состояния растяжения – как на этом же участке на здоровой руке.

Стабилизация лопаток - активация передней зубчатой мышцы, нижней трапецевидной мышцы и широчайшей мышцы спины - часто за день, в быту, не менее 10 раз.

Стоя, макушкой тянемся вверх, лопатки свести к позвоночнику, сместить вниз, прижать низ лопаток к грудной клетке. Руки расслабить. Удерживать данное положение 30сек.

Аналогично с рукой на нижнем угле лопатки, с прилеганием лопаток к стене, а также движение лопатки по нижней половине циферблата часов: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, затем 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. По два прохода.

Стабилизация лопаток – при подъеме и опускании рук через стороны до 90 град. Лопатки с двух сторон должны подниматься и опускаться симметрично, но в два раза медленнее рук. Отслеживаем процесс при помощи 2х зеркал, либо видеофиксации. Повторить 5-10 раз. Выполнять 4-5 раза в день.

В следующем упражнении растяжение должно быть между лопаткой и плечом: Плечевой сустав во время выполнения упражнения вверх не поднимаем.

Тракция плечевого сустава. С 2х недель от операции. Подкладываем под среднюю треть плечевой кости валик/скрученное полотенце, диаметр около 5см. Кисть здоровой руки обхватывает плечо травмированной руки, выше локтя. Мягко давим здоровой кистью на плечо травмированной руки, добиваясь перемещения плеча к туловищу - получаем тракцию в плечевом суставе, 1 раз в 1 сек. Повторяем в течение 1-2 мин. Не меньше 5 раз в день. Лучше, через каждый час. Оперированная рука должна быть расслаблена. Лопатка стабилизирована.

g

Работа над увеличением пассивного объема движений в суставе - начинается со 2-5 недели. **Пассивно!! Крайне аккуратно, медленно, без боли!!** Выполняем 5-6 раза в день. Перед выполнением каждого упражнения – стабилизация лопаток! И во время выполнения упражнений на увеличение объема активных движений – лопатка прилежит к грудной клетке, смещена вниз и к центру.

Упражнения с блоком на межкомнатной двери выполняются на расслабленной дельтовидной мышце и стабильной лопатке:

1. **Сгибание.** С блоком на межкомнатной двери, лицом к двери. Перекидываем пояс через межкомнатную дверь, концы пояса расположены по обе стороны двери. Один конец пояса захватываем в кулак здоровой рукой, второй конец пояса образует петельку, туда вкладываем оперированную руку. Оперированная рука перед собой, **расслаблена**, прямая, большой палец указывает на потолок. Начинаем перемещать здоровую руку вниз - травмированная рука перемещается вверх. На наступающем дискомфорте задерживаемся на 30 сек. Если дискомфорт прошел, идем дальше, задерживаемся еще на 15 сек. Руку вниз не опускаем, все время идем наверх. Повторяем 3 раза. 5-6 раза в день. **Плечевой сустав в процессе выполнения упражнения вверх не поднимаем! Лопатка стабильна! Допустимо сгибание в локтевом суставе.**
2. **Отведение.** С блоком на межкомнатной двери, боком к двери. Перекидываем пояс через межкомнатную дверь, концы пояса расположены по обе стороны двери. Один конец пояса захватываем в кулак здоровой рукой, второй конец пояса образует петельку, туда вкладываем оперированную руку. Оперированная рука отведена в сторону, **расслаблена**, прямая, большой палец указывает на потолок. Начинаем перемещать здоровую руку вниз - травмированная рука перемещается вверх. На наступающем дискомфорте задерживаемся на 30 сек. Если дискомфорт прошел, идем дальше, задерживаемся еще на 15 сек. Руку вниз не опускаем, все время идем наверх. Повторяем 3 раза. 5-6 раза в день. **Плечевой сустав в процессе выполнения упражнения вверх не поднимаем! Лопатка стабильна! Допустимо сгибание в локтевом суставе.**
3. **Наружная ротация нижняя.** Стоя, около шкафа, боком к нему. Оперированная рука согнута в локте, прижата к туловищу, ладонь травмированной расположена на стенке шкафа, во время движения ладонь не меняет своего положения. Осуществляем поворот туловища в противоположную сторону от руки - удаляясь от нее. Положение локтя также остается неизменным. На наступающем дискомфорте задерживаемся на 30 сек. Если дискомфорт прошел, идем дальше, задерживаемся еще на 15 сек. Повторяем 3 раза. 5-6 раза в день. **Плечевой сустав в процессе выполнения упражнения вверх не поднимаем! Лопатка стабильна!**



4. **Наружная ротация верхняя.** Стоя, около шкафа, боком к нему. Оперированная рука отведена на 90 град, или ниже. И согнута в локтевом суставе примерно на 90 град. Ладонь и плечевая кость травмированной руки расположена на стенке шкафа, во время движения ладонь не меняет своего положения. Осуществляем поворот туловища в противоположную сторону от руки - удаляясь от нее. Положение локтя также остается неизменным. На наступающем дискомфорте задерживаемся на 30 сек. Если дискомфорт прошел, идем дальше, задерживаемся еще на 15 сек. Повторяем 3 раза. 5-6 раза в день. **Плечевой сустав в процессе выполнения упражнения вверх не поднимаем! Лопатка стабильна!**



5. **Внутренняя нижняя ротация.** Стоя у шкафа, боком к нему. Оперированная рука согнута в локтевом суставе около 120 град, плечо прилежит к шкафу, в сгибании около 60 град. Ладонь здоровой руки расположена на лучезапястном суставе оперированной, сверху. Осуществляем здоровой рукой давление на оперированную - производим плавный поворот предплечья внутрь. Положение локтя также остается неизменным. Стремимся к заведению руки за спину. В дальнейшем отходим от шкафа. Помогаем здоровой рукой - поясом от халата. На наступающем дискомфорте задерживаемся на 30 сек. Если дискомфорт прошел, идем дальше, задерживаемся еще на 15 сек. Повторяем 3 раза. 5-6 раза в день. **Плечевой сустав в процессе выполнения упражнения вверх не поднимаем! Лопатка стабильна!**



Упражнения в бассейне с всплывающим предметом, рука полностью должна быть погружена в воду:

На сгибание – рука прямая перед собой, на всплывающем предмете – делаем наклон туловища вперед, на отведение – рука прямая отведена в сторону, на всплывающем предмете – делаем наклон туловища в сторону. На наступающем дискомфорте задерживаемся на 30 сек. Повторяем 3 раза.

На наружную ротацию – предплечье прилежит к туловищу, рука согнута в локте под 90 град, предмет удерживается кистью. Начинаем поворачиваться в воде вокруг своей оси – преодолевая оперированной рукой сопротивление воды. 1-2 мин.

На внутреннюю ротацию, с 8 недели – рука заведена максимально за спину, в кисти всплывающий предмет. На наступающем дискомфорте задерживаемся на 30 сек. Повторяем 3 раза.

Растяжение задней капсулы, с 8 недели – рука прямая перед собой, в кисти всплывающий предмет. Начинаем поворачиваться в воде вокруг своей оси в сторону заинтересованной руки. 1 мин.

На укрепление наружных и внутренних ротаторов плеча – рука согнута в локте под 90 град, перед собой. Кистью удерживаем всплывающий предмет. Делаем малоамплитудные движения ротационные движения плечом кнутри и кнаружи. 1-2 мин.

Растяжение малой грудной мышцы – пальцы на 3-5 ребро, на 5 см от грудины, прижимаем плотно мышцу к грудной клетке, одновременно сводим лопатки. удерживаем 5 сек. Перемещаем пальцы выше на 2 см – по направлению к плечевому суставу, повторяем тоже самое. дальше все выше и выше. Доходим до плечевого сустава. 3 раза в день.

Стабилизация акромиально - ключичного сустава (АКС): делаем 4-6 сближающих движений ключицы и лопатки, с задержкой на 1-2 сек каждое. 1-2 раза в день.

Упражнение на переднюю порцию дельтовидной мышцы – рука пионера - плечо отведено от туловища в пределах 90 град, не выше, в локтевом суставе около 90 град, ротация плеча кнаружи около 45 град, ладонь развернута кпереди, расположена вертикально – с опорой на шкаф. Давим ладонью на шкаф (мягко)- по 8 счетов, количество повторений до умеренного утомления. Корпус вперед не наклоняем. 1-2 раза в день.

Упражнение на заднюю порцию дельтовидной мышцы – плечо отведено от туловища в пределах 90 град, не выше, в локтевом суставе около 90 град, внутренняя ротация плеча 45 град, ладонь смотрит в пол. Давим на шкаф локтем назад (мягко)- по 8 счетов, количество повторений до умеренного утомления. Корпус назад не наклоняем. 1-2 раза в день.

Упражнение на нижнюю трапецевидную мышцу – стоя спиной к столу, заинтересованная рука прямая, опущена вниз, кисть сжата в кулак, соприкасается со столом сзади. Начинаем оказывать давление кулаком на стол в направлении назад, без перемещения руки. Сохраняем данное напряжение 8 счетов. Количество повторений до умеренного утомления мышц.

Техника надавливание – вибрация ромбовидных мышц, массажером молекула, по внутреннему краю лопатки, требуется посторонняя помощь. Либо, самостоятельно - используем теннисный мячик в носке, располагаемся у стены. **Затем, упражнение на ромбовидные мышцы - максимально свести лопатки к центру**, как двери в лифте, руки согнуты в локтевых суставах, около 90 град, разведены в стороны - по 8 счетов удержание, количество повторений до утомления. 1-2 раза в день.

Техника надавливание - вибрация передней зубчатой мышцы – ладонь на противоположное плечо, рука согнута, вибрация ниже подмышечной области, чуть кпереди. Если больно, то уменьшаем давление и добавляем больше вибрации. **Затем, – упражнение на переднюю зубчатую мышцу** – прямая рука перед нами подержать бутылку воды, весом 0, 5 кг - ниже уровня плечевого сустава, на уровне плечевого сустава и выше уровня плечевого сустава, по 30 сек - 1 мин. 1-2 раза в день.

Упражнение на укрепление нижних стабилизаторов лопатки в динамике - лежа на животе, заинтересованная рука на краю кровати, свешена вниз, перпендикулярна полу. Осуществляем **гребок рукой**, до достижения в локтевом суставе 90 град сгибания. Далее, возвращаемся в исходное положение, **медленно**, в течение 8 счетов. Количество повторений до утомления. 1-2 раза в день. В кисти утяжелитель - 0, 5-1кг. Лопатки стабилизированы при перемещении руки и вверх и вниз.



Упражнение на укрепление нижних стабилизаторов лопатки в динамике - лежа на животе, заинтересованная рука на краю кровати, свешена вниз, перпендикулярна полу. Осуществляем **подъем - отведение** прямой руки не доходя до уровня горизонта. Далее, возвращаемся в исходное положение, **медленно**, в течение 8 счетов. Количество повторений до утомления. 1-2 раза в день. В кисти утяжелитель - 0, 5-1кг. Лопатки стабилизированы при перемещении руки и вверх и вниз.



Упражнение на укрепление подостной мышцы – лежа на боку со здоровой стороны, травмированная расположена сверху. Плечо прилежит к туловищу, расположено на валике шириной 5см. Рука согнута под 90 град, предплечье свешено вниз, касается туловища, в кисти утяжелитель 0, 5-1кг. Осуществляем **подъем** предплечья до уровня горизонта и затем, медленно, в течение 8 счетов, возвращаем руку в исходное положение. Количество повторений до утомления. 1-2 раза в день. В кисти утяжелитель - 0, 5-1кг. Лопатки стабилизированы при перемещении руки и вверх и вниз.

Упражнение на укрепление малой круглой мышцы – аналогично, но без валика.

Следующая консультация через 8 недели.

Врач Сивохина Екатерина Викторовна.